

สรุปกิจกรรม Journal Club

หัวข้อ: การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับวิสัญญีพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในห้องพักรฟื้น โรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย

วันที่กิจกรรม: 29 ธันวาคม 2568 เวลา 08.30-09.30 น.

ผู้นำเสนอกิจกรรม Journal Club :

นายอริยฉัตร กาพหว่า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นส.อมรรัตน์ นาทองไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นส.พิชญ์สินี นันทะรัตน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม Journal Club (Standard Template)

1. ข้อมูลทั่วไปของบทความ (Article General Information)

ชื่อบทความ: การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับวิสัญญีพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในห้องพักรฟื้น โรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย (Development of Nursing Practice Guideline for Nurse Anesthetists to Prevent Postpartum Hemorrhage after Cesarean Section in the Post-anesthesia Care Unit at Phayakkhaphumphisai Hospital)

ผู้พิมพ์และสถาบัน: นิติยา หวังสันติวงศา และคณะ โรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูลวารสาร: วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2567 หน้า 208-217

รูปแบบการศึกษา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)

2. บทนำ: ความเป็นมาและปัญหาที่ต้องแก้ไข (Introduction & Problem Statement)

ความสำคัญของปัญหา: ภาวะตกเลือดหลังคลอด (Postpartum Hemorrhage: PPH) เป็นภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมที่พบบ่อยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของมารดา 5 อันดับแรกทั้งในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและยังไม่พัฒนา โดยมีอัตราการเกิด 1 ต่อ 100,000 ถึง 1 ต่อ 1,000 การผ่าตัดคลอดการผ่าตัดคลอด

ทางหน้าท้องมีความเสี่ยงสูงกว่าการคลอดทางช่องคลอดเกือบ 3 เท่า สาเหตุหลักที่พบบ่อยที่สุดเกิดจากภาวะมดลูกไม่หดตัว (Uterine Atony) ผลต่อเนื่องจากภาวะตกเลือดหลังคลอดอาจทำให้เกิดภาวะช็อคจากการเสียเลือดปริมาณมาก ภาวะเลือดไม่แข็งตัว และอาจนำไปสู่การตัดมดลูกเพื่อรักษาชีวิต

สถานการณ์ปัญหาของโรงพยาบาล: โรงพยาบาลพญามณีนพรัตน์เป็นโรงพยาบาลขนาด M2 ที่ให้บริการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โดยมีอัตราการผ่าตัดคลอดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2565 คิดเป็นร้อยละ 23.65, 30.69, 43.16, 56.55 และ 57.55 ตามลำดับ ในช่วงไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2566 เกิดอุบัติการณ์การตกเลือดหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในห้องพักฟื้นรุนแรงจนต้องผ่าตัดซ้ำ (Reoperation) และตัดมดลูกจำนวน 2 ราย จากการทบทวนโดยทีมสหสาขาวิชาชีพพบว่าหน่วยงานวิสัญญีไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันของวิสัญญีพยาบาลแต่ละคน

ช่องว่างของความรู้" (Gap of Knowledge): โรงพยาบาลยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับวิสัญญีพยาบาลในการป้องกันภาวะตกเลือดหลังผ่าตัดคลอดในห้องพักฟื้น ทำให้การดูแลไม่เป็นมาตรฐานและอาจเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน

คำถามวิจัย (Research Question): ในการพัฒนาและนำแนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับวิสัญญีพยาบาลไปใช้ในมารดาหลังผ่าตัดคลอดที่พักรักษาในห้องพักฟื้น จะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์การป้องกันภาวะตกเลือดหลังผ่าตัดคลอดและระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน

3. วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)

- 1) เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับวิสัญญีพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะตกเลือด หลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในห้องพักฟื้น
- 2) เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลที่พัฒนาขึ้น
- 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของวิสัญญีพยาบาลต่อการใช้นโยบายปฏิบัติการพยาบาล

4. ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology)

รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ระยะเวลาดำเนินการ สิงหาคม 2565 - กันยายน 2566

กลุ่มตัวอย่าง: (1) กลุ่มที่ร่วมพัฒนาแนวปฏิบัติ ประกอบด้วย สูตินรีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล และพยาบาลห้องผ่าตัด จำนวน 10 คน (2) กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้แนวปฏิบัติ ได้แก่ วิสัญญีพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน

ห้องพักฟื้น 6 คน และมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องที่เข้าพักฟื้นในห้องพักฟื้น จำนวน 62 ราย (เมษายน-กันยายน 2566) โดยคัดมารดาที่มีภาวะตกเลือดขณะทำการผ่าตัดออก

เครื่องมือวิจัย: (1) แนวปฏิบัติการพยาบาลที่พัฒนาขึ้น (2) แบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยหลังการระงับความรู้สึก (3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อแนวปฏิบัติ (4) แบบสังเกตการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ

การวิเคราะห์ข้อมูล: สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่และร้อยละ

5. แนวปฏิบัติการพยาบาลที่พัฒนาขึ้น (The Developed Nursing Practice Guideline)

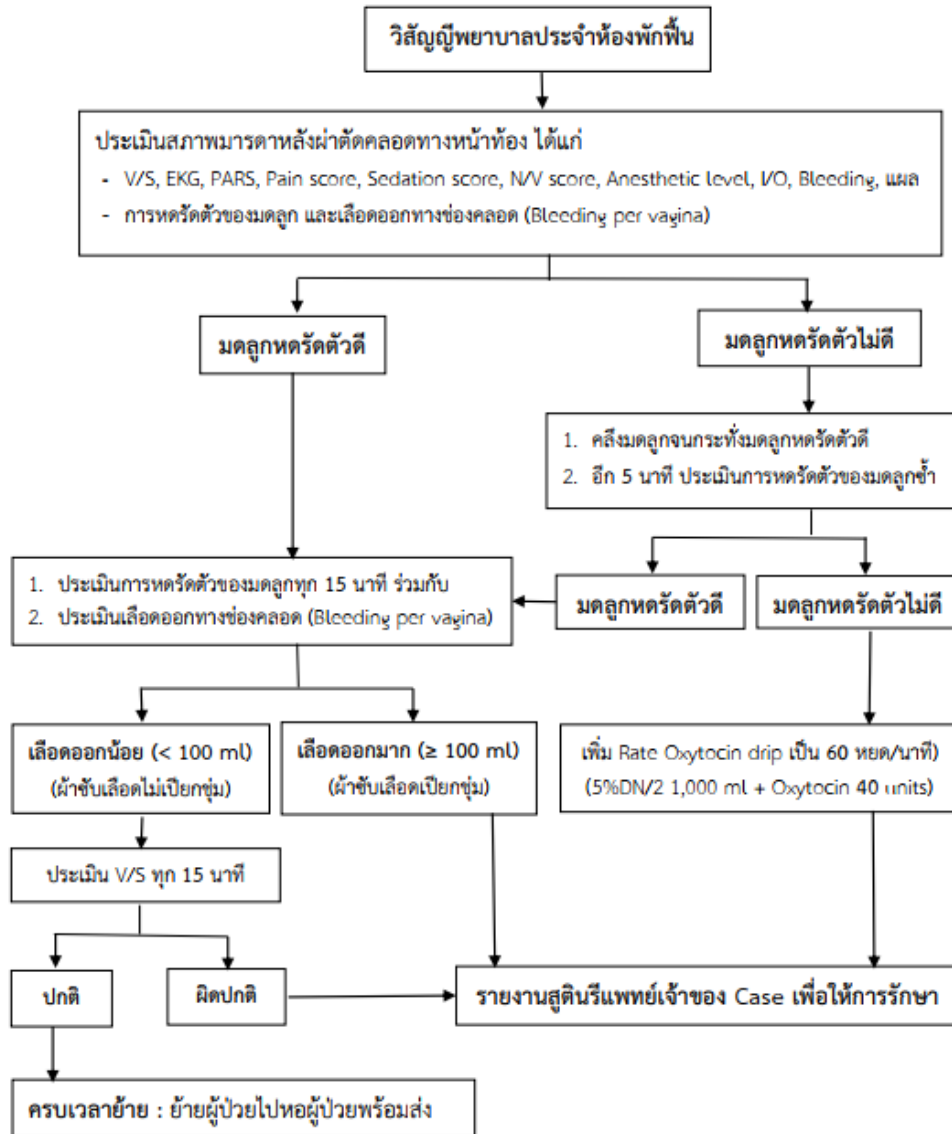
แนวปฏิบัติการพยาบาลที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังนี้:

- การประเมินสภาพผู้ป่วย: V/S, EKG, PARS, Pain score, Sedation score, N/V score, Anesthetic level, I/O, Bleeding, แผล
- การประเมินการหดตัวของมดลูก: ทุก 5-15 นาที
- การดูแลกรณีมดลูกหดตัวดี: ประเมินการหดตัวของมดลูกทุก 15 นาทีร่วมกับประเมินเลือดออกทางช่องคลอดและสัญญาณชีพ
- การดูแลกรณีมดลูกหดตัวไม่ดี: คลึงมดลูกจนหดตัวดี ประเมินซ้ำใน 5 นาที หากยังไม่ดีให้เพิ่ม Rate Oxytocin drip (5%DN/2 1,000 ml + Oxytocin 40 units) เป็น 60 หยด/นาที และรายงานสูตินรีแพทย์ทันที
- การประเมินเลือดออกทางช่องคลอด: หากมีปริมาณตั้งแต่ 100 ml ขึ้นไป (ผ้าซับเลือดเปียกชุ่ม) ให้รายงานแพทย์ทันที
- การรายงานแพทย์: เมื่อพบความผิดปกติของสัญญาณชีพ การหดตัวของมดลูก หรือเลือดออกทางช่องคลอดมาก
- การส่งต่อข้อมูล: ส่งต่อข้อมูลการผ่าตัด การระงับความรู้สึก อาการ การดูแลรักษา และผลของการดูแลแก่พยาบาลตึกหลังคลอด
- การจำหน่ายจากห้องพักฟื้น: เมื่อครบเวลาและผลการประเมินปกติ

โดยแสดงดังภาพ

**แผนผังแนวปฏิบัติสำหรับวิสัญญีพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะตกเลือด
หลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในท้องพักฟื้น โรงพยาบาลพริ้นซ์สมุทรปราการ**

1. วิสัญญีพยาบาลประจำห้องผ่าตัดส่งต่อข้อมูลการรับความรู้สึก และข้อมูลสิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง
2. พยาบาลส่งเครื่องมือส่งข้อมูล การวินิจฉัย การทำผ่าตัด ปัญหา และสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง



6. ผลการศึกษา (Results)

- ผลลัพธ์ด้านมารดาหลังผ่าตัดคลอด: จากมารดาหลังผ่าตัดคลอดทั้งหมด 62 ราย พบว่ามีภาวะมดลูกหดตัวดี 59 ราย (ร้อยละ 95.16) และมดลูกหดตัวไม่ดี 3 ราย (ร้อยละ 4.84) ซึ่งทั้ง 3

รายได้รับการปฏิบัติการพยาบาลตามแนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้น ส่งผลให้ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนตกเลือดหลังคลอด ไม่มีการผ่าตัดซ้ำ และไม่มีการตัดมดลูก มารดาหลังคลอดทุกรายปลอดภัย

- ผลลัพธ์ด้านการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ: บุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพิ่มขึ้นทุกด้าน ได้แก่ การประเมินสภาพผู้ป่วย (ร้อยละ 100) การประเมินการหดตัวของมดลูก (ร้อยละ 91.70) การดูแลกรณีมดลูกหดตัวดีและไม่ดี (ร้อยละ 91.70) การประเมินเลือดออกทางช่องคลอด (ร้อยละ 91.70) การรายงานแพทย์ (ร้อยละ 95) การส่งต่อข้อมูล (ร้อยละ 100) และการจำหน่ายจากห้องพักรักษา (ร้อยละ 100)
- ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจ: วิสัญญีพยาบาลทั้ง 6 คนมีความพึงพอใจต่อแนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นในระดับมากที่สุด โดยแนวปฏิบัติมีความเข้าใจง่าย (ร้อยละ 4.67) มีความสะดวกต่อการใช้ (ร้อยละ 4.67) ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในผู้ป่วย (ร้อยละ 4.83) สามารถให้การดูแลผู้ป่วย (ร้อยละ 4.83) และมีความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติจริง (ร้อยละ 4.67)

7. การวิพากษ์ผล (Critical Appraisal)

จุดแข็งของการวิจัย

- ใช้กรอบแนวคิด Evidence Based Practice Model ในการพัฒนาแนวปฏิบัติ ทำให้มีความน่าเชื่อถือและมีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ
- มีการมีส่วนร่วมของทีมนิสิตพยาบาลวิชาชีพในการพัฒนาแนวปฏิบัติ ทำให้ได้แนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับและสามารถนำไปใช้ได้จริง
- มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญและทดสอบความเชื่อมั่นก่อนนำไปใช้จริง
- ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าแนวปฏิบัติสามารถป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีผู้ป่วยต้องผ่าตัดซ้ำหรือตัดมดลูก

ข้อจำกัดของการวิจัย

- การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน เนื่องจากมีผู้รับบริการจำนวนมาก มีวิสัญญีประจำห้องพักรักษาเพียง 1 คน สิ่งแวดล้อมไม่เอื้อต่อการปฏิบัติ และมีการะงานอื่นที่ต้องปฏิบัติร่วมด้วย
- ไม่มีกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบ จึงไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าผลลัพธ์ที่ดีเกิดจากแนวปฏิบัติใหม่เพียงอย่างเดียว
- ระยะเวลาในการศึกษาค่อนข้างสั้น (6 เดือน) อาจไม่เพียงพอต่อการประเมินผลระยะยาว

ข้อเสนอแนะ

- ควรจัดสรรให้มีผู้ช่วยปฏิบัติงานในห้องพักฟื้น และมีอุปกรณ์ปิดกั้นเตียงนอนผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเปิดเผยผู้ป่วย
- ควรมีเครื่องมือช่วยประเเมนเลือดที่ออกทางช่องคลอดเพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว
- ผู้บริหารควรส่งเสริมให้แนวปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติการพยาบาลร่วมด้วย

8. บทสรุปและการนำไปใช้ (Conclusion & Take-home Message)

การศึกษานี้ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับวิสัญญีพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังผ่าตัดคลอดในห้องพักฟื้น และเมื่อนำไปใช้จริงพบว่าสามารถลดความเสี่ยงของมดลูกหดรัดตัวไม่ดีและไม่พบภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ขณะเดียวกันบุคลากรมีความพึงพอใจในระดับสูงต่อแนวปฏิบัติที่จัดทำขึ้น แสดงให้เห็นว่าแนวทางนี้สามารถนำไปใช้ในงานบริการได้จริง ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วยหลังผ่าตัดคลอดและยกระดับคุณภาพการดูแล จึงควรส่งเสริมให้ประยุกต์ใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาสื่อสนับสนุนหรือการขยายการใช้ในสถานพยาบาลอื่นได้ในอนาคต

Take-home Message: การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ เป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันภาวะตกเลือดหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในห้องพักฟื้น ซึ่งส่งผลให้การดาหลังคลอดปลอดภัยและลดอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง

9. เอกสารอ้างอิง (References)

นิติยา หวังสันติวงศา, บัณฑิต หวังสันติวงศา, นริศรา มาลี, และราตรี อันปัญญา. (2567). การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับวิสัญญีพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลพัยคหภูมิพิสัย. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, 9(6), 208-217.

รายชื่อผู้เข้าร่วม

นางยุพาวดี ภูวรรณ

นางละมัยศิลป์ เหมะธรินทร์

นางผ่องศรี นวลมณี

นางพัชรिता นพศรี

น.ส.สุภาลักษณ์ ทิพย์โยธา

นางปณณดา จิตรดามา

นางภัททิยา สุขสมบูรณ์

นางสุพัตรา สุวรรณมงคล

นายจิรพงษ์ การบุญ

นางไพรทอง บึงสุวรรณ

นางฐิตารีย์ บุญจันทร์

นายตั้งปณิธาน มุ่งเพ็ญ

น.ส.ชนิดาภา ศิริ

น.ส.เพียงใจ ผาใต้

น.ส.วิชุดา ขอนยาง

นายรัชพล ชาเหล่า

น.ส. สุมาลิน พลศักดิ์ขวา

น.ส. ศิริญา พานโฮม

น.ส.กรรณิกา อินทะรังษี

นายสมประสงค์ รัตนจุล

นางสิริลักษณ์ นาลงพรหม

นส.ปิยะรัตน์ บุญภิละ

นางนราทิพ ตั้งจิตประสงค์

นส.ศิวพร นาลงพรหม

นายจิตเดช ยืนยง

น.ส.วราภรณ์ บัวนาค

น.ส.ภัชวี วงศาพาน

นายอริยัญฎรภาพหว่า

นายโชคชัย วรบรรณากร

น.ส.กัลยกร วงษาเนาวิ

น.ส.จิฬาลักษณ์ มะลิรีน

น.ส.ฟ้ารุ่ง สุพรรณ

น.ส.พรพรรณ ยลมุกดา

นายพีระพงษ์ ชิมเมฆ

น.ส.สุพัตรา สิงพรมมา

นางฐิตินันท์ พุทธมาตย์

น.ส.อมรพรรณ กุลอินธิกาย

นายนำพล สุทธิสุวรรณ

นางธารา หอมจันทร์

น.ส.ฝนทิพย์ เจริญธรรม

น.ส.อมรรัตน์ นาทองไชย

น.ส.พิชญ์สินี นันทะรัตน์

น.ส.วิยะดา เนตรมหา

นายจักรชัย ตันเกษ

น.ส.อาภัสรา นามสง่า

นายอภิสิทธิ์ สุไชยราช

น.ส.ปราณี ภาวงศ์